

研究报告

Layer-1

seed=42

功能性二尖瓣反流（FMR）间接二尖瓣成形（IMA）文献锚定低阶代理探索性筛查报告

A literature-anchored low-order surrogate for exploratory screening of indirect mitral annuloplasty strategies

生成日期：2026-09-14 · 数据：run_pipeline.py --seed 42 --paper · 假设下最优候选：IMA-AP 双缝线 60% · AP 18.0% · physics 0.0735% · jet=central · P(feasible)≈0.86 · η top-1 稳定性 0.33

目录

- 摘要
- 背景与目标
- 数据与方法
- 研究过程
- 结果
- 分析与讨论
- 结论
- 局限性与展望
- 附录：图表与原始表
- 第十九节：双代理协作终报

一、摘要

中文摘要

背景：间接二尖瓣成形（IMA, indirect mitral annuloplasty, 不直接修补瓣叶而经装置重塑瓣环几何的介入策略）术前规划，常把计算文献中的缝线/桥缩短百分比直接当作前后径（AP, anteroposterior diameter, 二尖瓣环前后方向直径）缩减百分比。在本仓库 Galili 映射表约定下，IMA-AP 50% 峰缩期 AP=15.9 mm（近直接缩 AP；勿与未变形舒张期 34.4 mm 混用），70% 才塌缩至约 58% AP——后者是数值极端而非临床剂量。

方法：在可复现 Python 一层代理（代数力学代理 + SPH-inspired 文献校准泄漏代理）上实现 C1 假设剂量映射、C2 扫掠与情景排序、C3 LCx/NiTi 筛查，以及可选 C4 双缝线对照（ $\times 0.5$ 假设参数）。主图使用 physics 泄漏代理；YAML 混合仅限 Galili 校准/复现病例。

结果（seed=42）：评估 36 / 可行 30（ $P(\text{feasible}) \approx 0.86$ ）；假设下最优候选 **IMA-AP 双缝线 60%**（ $\eta=0.30 \rightarrow$ AP 缩减 **18.0%**，physics 泄漏代理 **0.0735%**，jet=central）。同剂量单缝线 jet=mixed。IMA-CS 可行最优桥缩短 **20%**（CS-LCx=**8.6 mm**）。 η top-1 稳定性 0.33（ $\eta \rightarrow$ 双 70%； $\eta+ \rightarrow$ 双 50%）。

结论：一层代理可编码 AP 窗口、射流位置与 LCx 风险筛查为探索性情景排序（非临床推荐）；不能替代患者特异 LHHM/FSI，不能把 η 当作新高保真力学辨识结果。

English abstract

A Layer-1 surrogate encodes AP dose, jet location, and LCx risk screening into an exploratory scenario ranker. Seed-42 best under assumptions: dual IMA-AP 60%, AP reduction 18.0%, physics leakage-proxy 0.0735%, jet=central. Not production FEA/SPH; η is an assumption prior.

Keywords: FMR; IMA; exploratory screening; coronary sinus; LCx; Layer-1 surrogate

二、背景与目标

功能性二尖瓣反流（FMR, functional mitral regurgitation）源于心室重塑、瓣环扩张、乳头肌移位与瓣叶对合不良。IMA-CS（经冠状窦路径，临床代表如 Carillon）与 IMA-AP（CS-IAS 缝线前后径收紧路径，概念上近 ARTO 类）不可机械等价。

目标：在 Level-1 代理上把计算缩短 % 翻译到解剖 AP 窗口，并在 LCx/NiTi 筛查约束下给出可复现网格情景排序。

诚实边界：不声称 first IMA-CS vs IMA-AP 比较；不把 physics % 等同临床反流容积；不把 $\eta \pm 20\%$ 写成高保真 UQ；不把校准/复现写成外部验证。

三、数据与方法

基线几何：瓣环周长 118.5 mm，AP 34.4 mm。临床映射 $(AP_reduction\% = \eta \times \text{shortening}\%)$ （IMA-AP $\eta=0.30$ ；IMA-CS $\eta \approx 0.55$ （假设先验，非 MAVERIC 拟合）；AP 上限 20%）。规划器最小化 physics_regurgitation_pct，约束含 CS-LCx ≥ 8.6 mm（文献筛查边界；默认基线 11.0 mm）与 NiTi 交变应变 $< 0.4\%$ 。

网格：IMA-AP 10–70%（步长 5%）；IMA-CS 10–25%（步长 2%）；双缝线同 AP 网格。论文图由 SciencePlots + Times New Roman、dpi ≥ 300 导出；轴标签保留英文，中文释义见图注长说明。

四、研究过程

- Level-0：离散 YAML 病例对齐 Galili 锚点（blended + physics 分列）。
- Level-1：假设映射扫描 $\rightarrow$ 情景排序 $\rightarrow$ scenario_ranking.json。
- paper 导出五图与 CSV 表。
- 本脚本将 PNG 转 base64、CSV 转 HTML 表，生成自包含报告。

五、结果

5.1 情景排序主结果

表 1. 情景排序主结果（clinical/假设映射，seed=42）

指标	数值
评估 / 可行	36 / 30
假设下最优候选	IMA-AP dual=2 @ 60.0%
AP 直径 / 缩减	28.208 mm / 18.0%
ROA	8.992 mm ²
physics 泄漏代理	0.0735%
jet / 交界分数	central / 0.165
备选单缝线 60%	physics 0.0754%, jet=mixed, commissural=0.330
备选 IMA-CS 20%	AP 11.000%, physics 0.1562%, CS-LCx=8.6 mm, NiTi=0.33999999999999997%

表 1 数字来自 planner/scenario_ranking.json（或兼容 shim），未经人工改写。

5.2 Galili 锚点

表 2. Galili vs surrogate（Level 0 校准/复现）

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	galili_roa_mm2
pathology	5.26	5.1483	4.8575	26.10	0.0735
ima_cs_22	0.29	0.2621	0.1425	24.80	4.8575
ima_ap_50	0.08	0.0793	0.0756	15.90	35.29

case_id	galili_regurgitation_pct	surrogate_blended_pct	surrogate_physics_pct	galili_ap_mm	galili_regurgitation_pct

5.3 临床窗口 vs 数值极端

表 3. 临床窗口 vs 数值极端

scenario	device	suture_or_bridge_pct	mapping_mode	ap_mm	ap_reduction_pct	ph
MAVERIC/ARTO pair 41.4→35.3 mm	ARTO (IMA-AP class)		clinical_literature	35.3	14.734	
MAVERIC/ARTO pair 45.0→38.7 mm	ARTO (IMA-AP class)		clinical_literature	38.7	14.0	
Carillon TITAN II AP context ~15%	Carillon (IMA-CS class)		clinical_literature		15.0	
Galili IMA-AP 50% suture (peak- systolic AP 15.9 mm)	IMA-AP	50.0	galili	15.9	39.08	0.0
Galili IMA-AP 70% suture (peak- systolic AP 12.4 mm)	IMA-AP	70.0	galili	12.4	52.49	5.0

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	60.0	18.0	True	0.0754
clinical	70.0	21.0	True	0.3911

5.6 主图（SciencePlots，base64 内嵌）

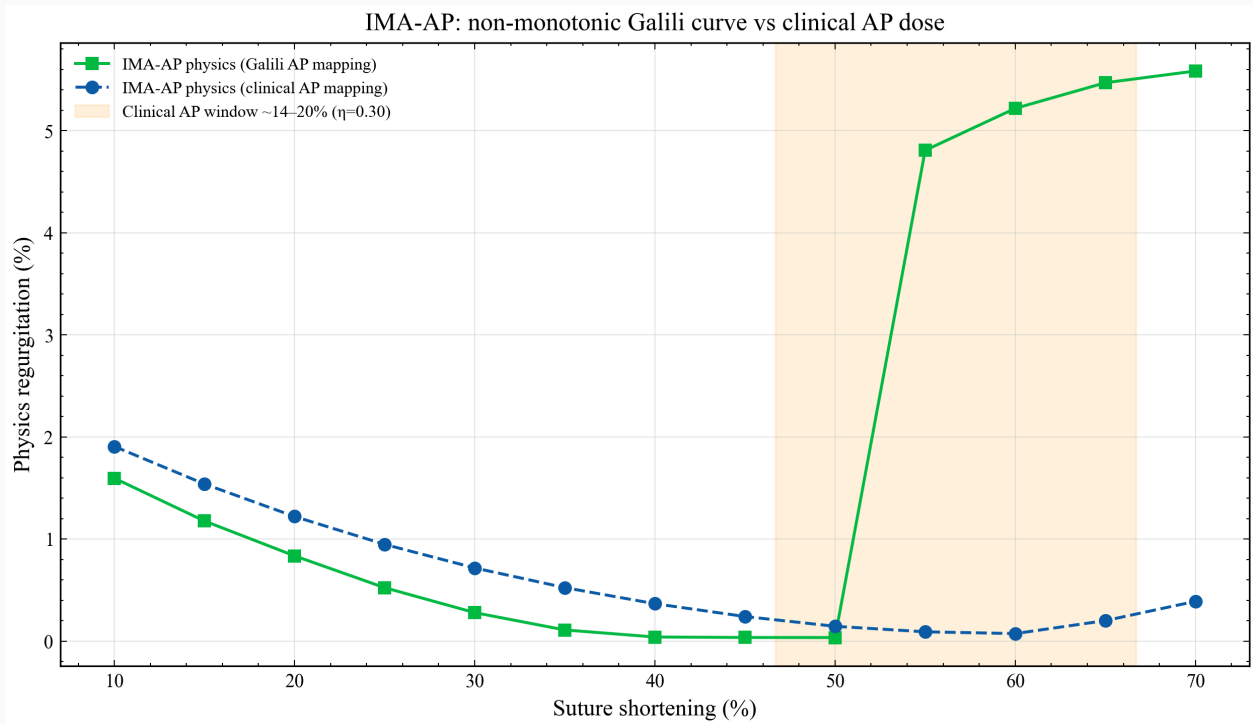


图 1. IMA-AP 物理反流随缝线缩短百分比的变化：Galili 映射 vs 临床映射

文件：fig1_ima_ap_nonmonotonic_clinical_window.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：本图回答“计算缝线缩短百分比能否直接当作临床前后径（AP）剂量？”

横轴为 IMA-AP 缝线缩短 %；

纵轴为 Layer-1 泄漏代理 physics_regurgitation_pct（代数力学代理 + 文献校准泄漏代理；不是超声反流容积分数）。

如何读：（1）Galili 映射复现发表峰缩期 AP：IMA-AP 50% → 峰缩期 AP=15.9 mm（相对疾病 26.1 mm 约 39% AP 缩减），

并非未变形舒张期 34.4 mm / 0% AP；70% → 12.4 mm 并交界区泄漏升高。（2）规划映射采用假设先验

$AP_reduction\% = \eta \times shortening\%$ ，默认 $\eta_{ap}=0.30$ （假设，非临床标定），使 50% 缝线对应约 15% AP，落入

ARTO/MAVERIC（IMA-AP 类，不是 Carillon）约 14–15% 对话窗口。绿色带为约 14–20% AP 窗口。

结论（仅限本代理）：规划映射下窗口内总体可筛查；Galili 峰缩期映射下 70% 非单调恶化。

勿将纵轴等同临床试验反流容积。

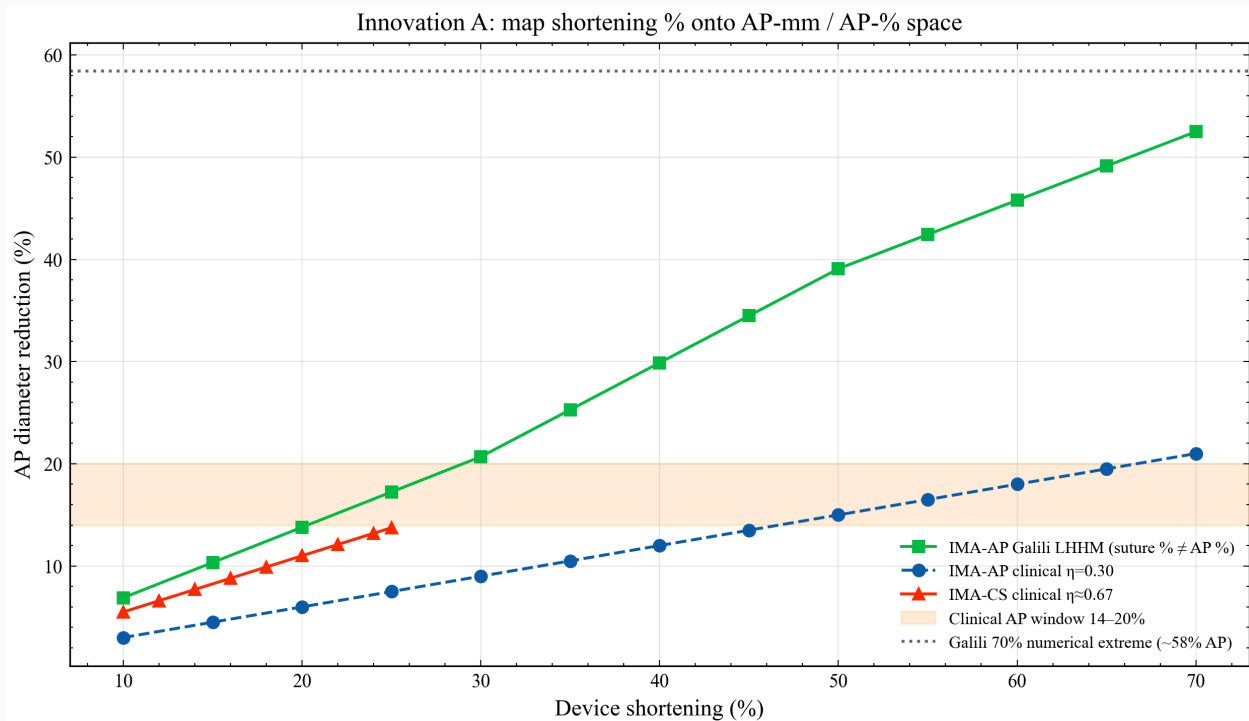


图 2. 装置缩短百分比到 AP 直径缩减百分比的剂量映射

文件: fig2_suture_vs_ap_reduction.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 横轴为缩短 %; 纵轴为 AP 缩减 %。轨迹对照: Galili 峰缩期 (IMA-AP 近直接缩 AP)、

规划 IMA-AP (假设 $\eta_{ap}=0.30$)、规划 IMA-CS (假设 $\eta_{cs}=0.55$, 非 MAVERIC 拟合; Carillon/TITAN II ~15% 仅语境)。

MAVERIC=ARTO (IMA-AP 类)。水平带 14–20% 为探索性规划窗口。

如何读: 同一缩短 % 在不同映射下 AP 缩减截然不同。 η 为假设先验, 不是成像–力学辨识, 也不是“临床标定常数”。

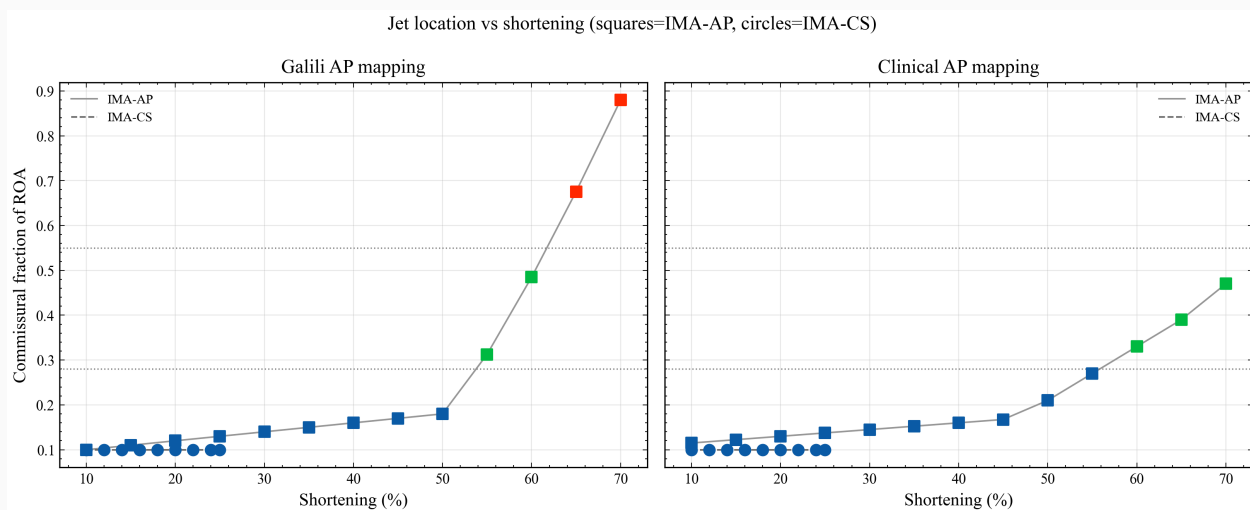


图 3. 射流位置与交界区 ROA 分数随缩短变化（Galili vs 临床）

文件: fig3_jet_location.png (SciencePlots + Times New Roman, dpi≥300; 坐标轴为英文标签, 释义见下文中文说明)

来龙去脉与读图说明: 反流“量”之外, 筛查还关心泄漏机制位置。本代理将 ROA (regurgitant orifice area,

反流口面积, 单位 mm^2 , 由对合间隙等代理量估计) 拆为中央份额与交界区份额, 并分类为 central /

commissural / mixed。横轴为缩短 %; 纵轴为交界区 ROA 分数; 方块=IMA-AP, 圆点=IMA-CS; 左右面板对照

Galili 与临床映射。水平虚线为分类阈值示意。双缝线 $\times 0.5$ 为显式假设参数, 不是独立“发现”。

如何读: 交界区分数升高意味着泄漏更偏交界区; 分类从 central 变为 mixed/commissural 表示机制标签切换。

该标签是代理口上的机制草图, 不是超声 PISA (proximal isovelocity surface area) 或多普勒诊断。

seed-42 假设下最优候选双缝线 60% 的机制来源可在本图与图 5 对照中追溯: 同 AP 下交界份额更低、jet 保持 central。

结论: 在临床映射下, IMA-AP 高剂量单缝线更易出现 mixed; IMA-CS 在可行桥缩短范围内多保持 central。

结合图 5, 双缝线可在匹配 AP 缩减下压低交界区分数 (假设情景)。

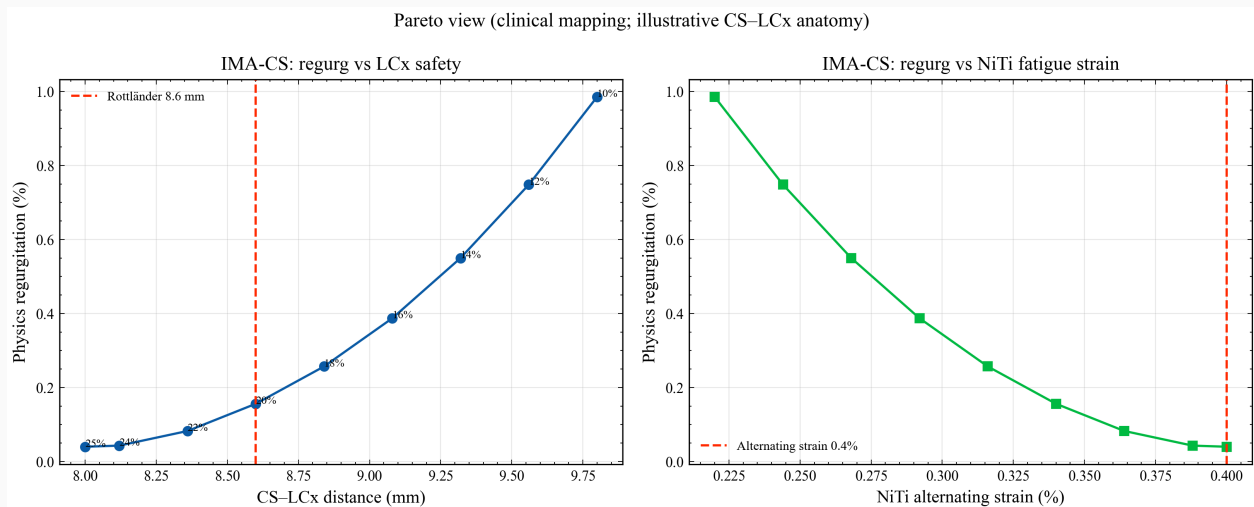


图 4. IMA-CS 临床映射：反流-筛查 Pareto（CS-LCx 与 NiTi 交变应变）

文件：fig4_pareto_lcx_strain.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：IMA-CS 在降低反流的同时可能压缩 CS-LCx 距离（coronary sinus-left circumflex artery，

冠状窦与左回旋支间距）。文献筛查边界取远端着陆区 CS-LCx ≥ 8.6 mm（Rottländer 等；注意：<8.6 mm

预测妥协 ≠ ≥8.6 mm 已证明安全）。同时对 NiTi（镍钛合金桥）交变应变设置 <0.4% 的工程筛查上限。

默认示意解剖基线 CS-LCx=11.0 mm，可替换为患者 CT。标题用“筛查”而非“安全证明”。

如何读左右面板：横轴多为筛查指标（CS-LCx 或交变应变），纵轴为 physics 反流；点随桥缩短移动，

越接近约束边界，可行域越窄。22% 及以上在默认解剖上常因 CS-LCx 违约束而不可行。

结论：默认解剖上可行最优贴近 CS-LCx=8.6 mm 的桥缩短 20%。该结果是规划器筛查信号，不是患者级安全证明。

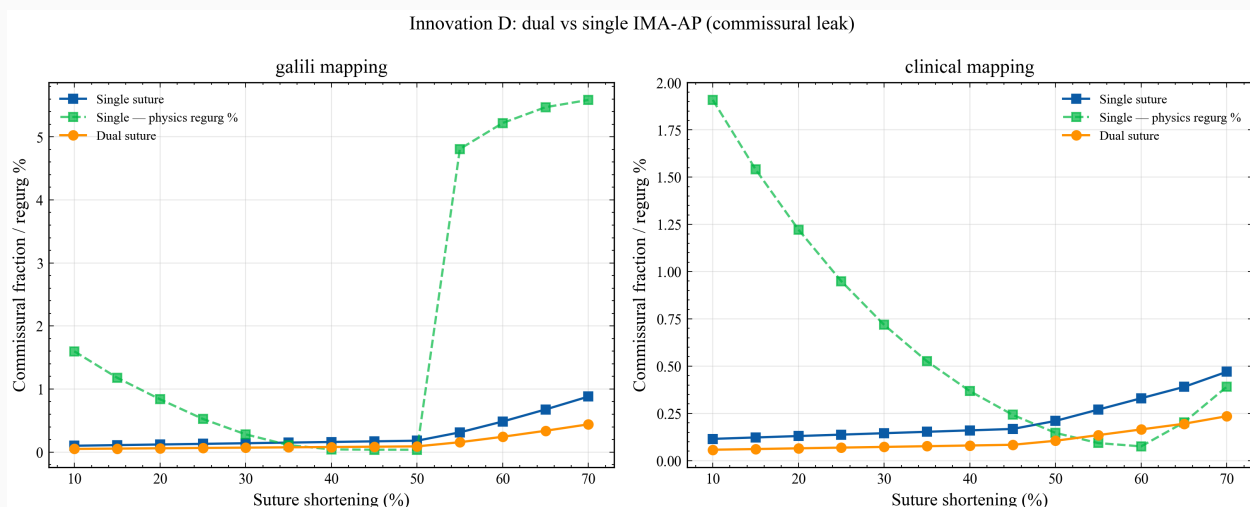


图 5. 双缝线 vs 单缝线 IMA-AP：匹配 AP 缩减下的交界区泄漏对照

文件：fig5_dual_vs_single_suture.png（SciencePlots + Times New Roman，dpi≥300；坐标轴为英文标签，释义见下文中文说明）

来龙去脉与读图说明：可选贡献 C4（Innovation D）在相同缝线缩短 %（故相同临床 AP 缩减）下比较单/双缝线。

纵轴关注交界区 ROA 分数；虚线可叠加单缝线 physics 反流作对照。左右面板对照 Galili / 临床映射。

本图隔离“缝线数量”变量，回答机制问题，不是器械清关或产品声明。

如何读：在 60% 临床映射点，单缝线 jet=mixed、交界分数 0.330；双缝线 jet=central、交界分数 0.165，

physics 泄漏代理理由约 0.075% 降至约 0.074%——分类改善更醒目，幅度改善相对温和。70% 点 AP 缩减 21%

超出默认 20% 规划上限，仅作机制对照，不作植入候选声明。双缝线交界因子 $\times 0.5$ 为显式假设参数。

结论：双缝线是假设生成情景；seed-42 场景排序最优候选双缝线 60% 正是在该对照下选出的网格点。

勿将 $\sim 0.074\%$ physics 等同于临床反流容积改善。

六、分析与讨论

- 剂量语义：Galili 峰缩期 IMA-AP 50% AP=15.9 mm（疾病 26.1 mm）；勿与未变形舒张期 34.4 mm 混用。
- ARTO/MAVERIC ~14–15% AP 为 IMA-AP 语境；Carillon/TITAN II 另作 IMA-CS 语境；REDUCE-FMR 仅方向性。
- CS-LCx 8.6 mm 为文献风险筛查边界；默认示意解剖 CS 20% 贴边可行。
- 双缝线主要改善 jet 分类（ $\times 0.5$ 假设参数）；physics 降幅温和。
- $\eta \pm 20\%$ 改变最优候选（双 70% 或双 50%）；top-1 稳定性约 0.33，无单一稳定“推荐”。

七、结论

在 seed-42 与默认约束下，Layer-1 情景排序假设下最优候选 **IMA-AP 双缝线 60%**，AP 缩减 **18%**，physics 泄漏代理 **0.0735%**，jet=central。该输出是可追溯探索性筛查结果，不是治疗处方。

八、局限性与展望

1. 无在线 Abaqus/LHHM 耦合（Level 2：待补充）。
2. η 非成像–力学成对辨识（待补充）； η_{CS} 非 MAVERIC 拟合。
3. 默认 CS-LCx=11 mm 示意解剖（患者 CT：待补充）。
4. 射流分类非超声 PISA/多普勒。
5. 网格点报告，非连续旋钮。
6. 双缝线为机制草图。

九、附录：更多表格

方向性对齐

表 A1. MAVERIC / REDUCE-FMR 方向性对齐（幅度不混用）

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	me
MAVERIC literature (ARTO)	ARTO (IMA-AP class)	41.4→35.3 mm	14.734	(not used as surrogate target)	AP↓	
MAVERIC literature (ARTO)	ARTO (IMA-AP class)	45.0→38.7 mm	14.0	(not used as surrogate target)	AP↓	
Carillon TITAN II context	Carillon (IMA-CS class)	~15% AP context	15.0	(not used as η _CS fit)	AP↓	
REDUCE-FMR literature	Carillon (IMA-CS class)	device vs sham		regurgitant volume ↓ (trial direction)	regurg↓	

source	device_or_arm	setting	ap_reduction_pct	regurg_metric	literature_direction	meta
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 50.0% n_sutures=1	15.0	physics regurg 0.1467% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
Layer-1 clinical mapping	IMA-AP	IMA-AP 60.0% n_sutures=2	18.0	physics regurg 0.0735% (jet=central)	AP↓, regurg↓	AF
alignment policy	—	directionality only		—	AP↓ (ARTO/MAVERIC; Carillon TITAN II context); regurg↓ (REDUCE-FMR)	AF reg 14

case_metrics

表 A2. case_metrics.csv

case_id	device	shortening_pct	annulus_circumference_mm	ap_diameter_mm	roa_mm2
pathology			118.5	26.1	148.30309519352
ima_cs_14	IMA- CS	14.0	116.272727272727	25.5	21.664246390998
ima_cs_18	IMA- CS	18.0	115.636363636364	24.7	15.738788296201
ima_cs_22	IMA- CS	22.0	115.0	24.8	11.372958300435
ima_ap_30	IMA- AP	30.0	117.0	20.7	13.309908895861
ima_ap_50	IMA- AP	50.0	116.0	15.9	25.494430293815
ima_ap_70	IMA- AP	70.0	115.0	12.4	125.49545772100

Pareto / 可行域全表

表 A3. pareto_regurg_vs_safety.csv

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-CS	0	10.0	0.9851	5.5	9.8	0.22
IMA-CS	0	12.0	0.7481	6.6	9.56	0.244
IMA-CS	0	14.0	0.5499	7.7	9.32	0.268
IMA-CS	0	16.0	0.3872	8.8	9.08	0.292
IMA-CS	0	18.0	0.257	9.9	8.84	0.316
IMA-CS	0	20.0	0.1562	11.0	8.6	0.34
IMA-CS	0	22.0	0.0826	12.1	8.36	0.364
IMA-CS	0	24.0	0.0432	13.2	8.12	0.388
IMA-CS	0	25.0	0.0401	13.75	8.0	0.4
IMA-AP	1	10.0	1.9084	3.0		
IMA-AP	1	15.0	1.5407	4.5		
IMA-AP	1	20.0	1.2221	6.0		
IMA-AP	1	25.0	0.9493	7.5		
IMA-AP	1	30.0	0.7182	9.0		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	1	35.0	0.5255	10.5		
IMA-AP	1	40.0	0.368	12.0		
IMA-AP	1	45.0	0.2424	13.5		
IMA-AP	1	50.0	0.1467	15.0		
IMA-AP	1	55.0	0.0927	16.5		
IMA-AP	1	60.0	0.0754	18.0		
IMA-AP	1	65.0	0.2023	19.5		
IMA-AP	1	70.0	0.3911	21.0		
IMA-AP	2	10.0	1.913	3.0		
IMA-AP	2	15.0	1.5447	4.5		
IMA-AP	2	20.0	1.2255	6.0		
IMA-AP	2	25.0	0.9518	7.5		
IMA-AP	2	30.0	0.7201	9.0		
IMA-AP	2	35.0	0.5268	10.5		
IMA-AP	2	40.0	0.3688	12.0		
IMA-AP	2	45.0	0.2429	13.5		

device	n_sutures	shortening_pct	physics_regurgitation_pct	ap_reduction_pct	cs_lcx_mm	niti_al
IMA-AP	2	50.0	0.1465	15.0		
IMA-AP	2	55.0	0.0913	16.5		
IMA-AP	2	60.0	0.0735	18.0		
IMA-AP	2	65.0	0.116	19.5		
IMA-AP	2	70.0	0.1663	21.0		

双缝线全表

表 A4. dual_vs_single_matched_ap.csv

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	10.0	3.0	True	1.9084
clinical	15.0	4.5	True	1.5407

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	20.0	6.0	True	1.2221
clinical	25.0	7.5	True	0.9493
clinical	30.0	9.0	True	0.7182
clinical	35.0	10.5	True	0.5255

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	40.0	12.0	True	0.368
clinical	45.0	13.5	True	0.2424
clinical	50.0	15.0	True	0.1467
clinical	55.0	16.5	True	0.0927

mapping_mode	suture_shortening_pct	ap_reduction_pct	ap_matched	single_physics_regurgitation_
clinical	60.0	18.0	True	0.0754
clinical	65.0	19.5	True	0.2023
clinical	70.0	21.0	True	0.3911

十九、双代理协作终报

角色：Cursor = 唯一实现与核验；ChatGPT = 纯文本顾问（无文件上传）。本轮：≥5 轮稿件成熟化；公开 GitHub 推送文档供顾问重读。

GitHub（公开）： <https://github.com/Coucou2016/fmr-ima-layer1-planner> — README、docs/paper_framework_nature.md、docs/manuscript_draft.md、docs/chatgpt_collab/rounds/。

Commit / push： 见终报 Markdown 表与 docs/chatgpt_collab/20260816_five_round_final.md；分支 main；PUBLIC。

ChatGPT URL： <https://chatgpt.com/c/6a807186-6f88-83ea-afc5-49dddcff3a65>（Senior Review）。各轮 ready brief 见 docs/chatgpt_collab/rounds/round_ON.md。

ChatGPT 浏览器状态：BLOCKED — 无 browser MCP / 标签页不可用。五轮均为本地成熟化：既有文献回复 + WebSearch + nature-skills。未虚构任何新的 ChatGPT 回复。

Baseline： seed-42（dual 60% / AP 18% / physics (see JSON) / central）、SciencePlots 五图、golden tests、成熟化后的 manuscript / report / paper。

已采纳： 规划/翻译层新颖性；Galili 表约定；LCx/NiTi 筛查措辞；physics≠临床反流容积；Intro/Discussion nature-writing 抛光；Results 来龙去脉；Methods claim audit。

拒绝： Layer-1=LHHM；first CS-vs-AP；≥8.6 mm=safe； $\eta \pm 20\%$ =FEA UQ；旗舰 Nature 无证据升级。

本轮新增/更新文件：

- docs/manuscript_draft.md
- docs/paper_framework_nature.md
- docs/paper.html
- docs/paper.md
- docs/paper.pdf
- report.html
- report.md
- report.pdf
- docs/report.html
- docs/report.md
- tools/package_reports.py

- docs/chatgpt_collab/rounds/round_01.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_02.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_03.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_04.md
- docs/chatgpt_collab/rounds/round_05.md
- docs/chatgpt_collab/20260816_five_round_final.md

测试： PASS — PYTEST_DISABLE_PLUGIN_AUTOLOAD=1 pytest tests/ -q (40 passed); PASS — python run_pipeline.py --seed 42 --paper --no-export (planner: IMA-AP dual 60%, AP 18.0%, physics (see JSON), jet=central)

PDF： 生成中

风险： HTML 因 base64 变大；示意解剖与 η 限制外推；Level-2 待补充；ChatGPT GitHub 审阅回复待浏览器恢复后补档。

范围： 公开 GitHub 推送已完成；无 PR；无 deploy。